

ORIGINAL



GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

4^{ta.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 867

INFORME POSITIVO

17 de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del **Proyecto del Senado 867**, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación, con las enmiendas que se incluyen en el Entirillado Electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El **Proyecto del Senado 867** propone crear la "Ley de la Reforma Médica para la Eficiencia, Salud y Agilidad", a los fines de crear eficiencia, transparencia y agilidad en la operación del sistema de salud de Puerto Rico mediante la regulación del proceso de reclamaciones sometidas por los proveedores de servicios de salud a las aseguradoras o planes médicos, tanto en la esfera privada como bajo el Plan Vital; para crear el Fondo REMESA; y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Según se desprende de la Exposición de Motivos de la medida, el sistema de salud de Puerto Rico enfrenta una crisis estructural que afecta la calidad, continuidad y eficiencia de los servicios médicos. Los hospitales se encuentran operando bajo presión financiera severa debido a tarifas insuficientes, alza en costos operacionales y, especialmente, retrasos prolongados en los pagos provenientes de las aseguradoras. Los proveedores de servicios de salud, incluyendo médicos, subespecialistas, hospitales, laboratorios, centros de salud, proveedores de salud mental y profesionales aliadas, experimentan una carga

administrativa extrema producto de procesos burocráticos lentos, reclamaciones denegadas, redes cerradas y demoras injustificadas en credencialización. Los médicos subespecialistas enfrentan una crisis particular debido a la dificultad para integrarse a redes, la falta de incentivos contributivos, los procesos engorrosos de certificación y los altos costos de sus préstamos estudiantiles.

El sistema de reclamaciones vigente carece de eficiencia y transparencia. La ausencia de un método obligatorio de pago electrónico automático permite que los atrasos en pagos se extiendan por semanas o meses, afectando directamente la operación de hospitales y proveedores.

Esta Ley regula específicamente el proceso de reclamaciones sometidas por los proveedores de servicios de salud a las aseguradoras o planes médicos, tanto en la esfera privada como bajo el Plan Vital. Además, regula la relación operacional entre el Gobierno, los proveedores de salud y los planes médicos, asegurando uniformidad, claridad y eficiencia en el procesamiento de reclamaciones.

El Plan Vital maneja entre \$2,200 y \$2,400 millones anuales, fondos que deben utilizarse de forma transparente, estratégica y eficiente. Es imperativo garantizar que estos recursos se distribuyan apropiadamente para fortalecer la infraestructura hospitalaria, retener profesionales y asegurar servicios médicos oportunos.

La Ley REMESA moderniza el sistema mediante la implementación de pagos automáticos obligatorios, apertura de redes, procesos de credencialización acelerados, auditorías periódicas y la creación de un Fondo de REMESA para promover la estabilidad financiera y profesional del sistema de salud.

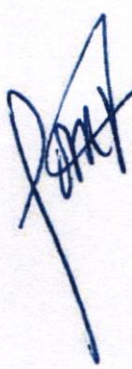
ALCANCE DEL INFORME

Como parte del proceso de análisis y evaluación del P. del S. 867, la Honorable Comisión de Salud del Senado solicitó los comentarios sobre la medida a diversos componentes gubernamentales y no gubernamentales. Los memoriales recibidos y utilizados para el análisis de esta pieza legislativa son: el Departamento de Salud, la Administración de Seguros de Salud (ASES), la Oficina Comisionado de Seguros (OCS), la Asociación de Compañías de Seguro (ACODESE), la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, la Asociación Médica de Puerto Rico (AMPR), la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico, el Plan de Salud Menonita (PSM) y MMM Holdings, LLC.

Igualmente, se solicitaron los comentarios a la Asociación Farmacias de la Comunidad, Colegio de Médicos, First Medical, Triple- S, pero, al momento de rendir el presente informe, no habían sido remitidos a la Comisión

A continuación, presentaremos un resumen de los argumentos y comentarios esbozados por las diferentes agencias, entidades y ciudadanos consultadas durante el proceso de evaluación de la medida en referencia.

DEPARTAMENTO DE SALUD



El **Departamento de Salud** compareció ante esta Ilustre Comisión, por conducto de su Secretario, Dr. Victor M. Ramos Otero, endosando el Proyecto del Senado 971 de forma condicionada, sujeto a que se acojan sus recomendaciones dirigidas a asegurar el estricto cumplimiento con el marco regulatorio federal. Planteó que, sin estas modificaciones, la implementación de la medida pondría en grave riesgo el financiamiento y la viabilidad del Programa Medicaid y del Plan Vital en la Isla.

La Agencia reveló que, conforme su deber constitucional, a través de su División de Asistencia Médica, administra el Programa Medicaid bajo el Título XIX de la Ley de Seguridad Social federal, garantizando que la población médico indigente reciba servicios de excelencia y que los procesos operacionales se mantengan alineados con las directrices de Washington.

El Departamento manifestó concurrir plenamente con los objetivos principales la pieza legislativa, reconociendo la urgencia de agilizar los procesos de pago a los proveedores de servicios médicos y mitigar la presión financiera que sufren los hospitales. No obstante, advirtió que cualquier disposición que incida sobre los fondos y la estructura del Plan Vital debe evaluarse con extremo cuidado para no violar normativas federales obligatorias.

Una de las mayores preocupaciones planteadas fue la creación del Fondo REMESA utilizando una reserva de entre el 5% y el 10% del presupuesto del Plan Vital. El Departamento de Salud señaló que el uso de estas partidas para el repago de préstamos estudiantiles de subespecialistas o incentivos regionales tiene una elegibilidad dudosa ante el Gobierno Federal y podría alterar drásticamente las tarifas de capitalización previamente aprobadas por las entidades regulatorias.

A nivel operacional, planteó que la reducción del tiempo de adjudicación a 15 días y la obligación de pagar en 24 horas reduce de forma peligrosa el margen para detectar el fraude, desperdicio y abuso. Acentuó, que la reglamentación federal impone al programa el deber afirmativo de implementar controles de integridad previos al pago, por lo que una presunción automática de validez de las reclamaciones vulneraría directamente este mandato de supervisión fiscal.

Asimismo, el Departamento de Salud advirtió que la propuesta de aplicar una tasa de interés moratorio del 0.5% diario por retrasos equivale a un cargo anual desproporcionado del 182.5%, lo cual excede los estándares permitidos en el manejo de fondos federales. Del mismo modo, esbozó que el acceso completo a la información de los planes médicos regulados por el Estado debe articularse formalmente con las protecciones de privacidad y confidencialidad exigidas por la ley federal HIPAA.

Ante este panorama, la recomendación principal de la Agencia fue condicionar expresamente la vigencia de las disposiciones aplicables al Programa Medicaid a la aprobación previa de un Enmienda al Plan Estatal (SPA) por parte de los *Centers for Medicare & Medicaid Services* (CMS). Según explicó, esto evitaría que cualquier dislocación regulatoria resulte en una pérdida de fondos que deba ser cubierta en su totalidad por el Gobierno.

Además, solicitó excluir al Programa Medicaid del mecanismo de aceptación y validación automática de reclamaciones para preservar los mecanismos de auditoría interna, así como modificar el texto del Proyecto para ajustar la tasa de intereses moratorios a un estándar razonable que resulte compatible con la reglamentación y las métricas del derecho federal.

Finalmente, el Departamento de Salud recomendó enmendar la medida para identificar explícitamente una fuente de financiamiento estatal exclusiva para nutrir el Fondo REMESA, desvinculándola por completo de las subvenciones federales de Medicaid. Concluyó que, con la incorporación de estas salvaguardas legales y financieras, se viabilizará la aprobación de la pieza legislativa objeto de evaluación, logrando una reforma que verdaderamente optimice el sistema de reclamaciones sin poner en riesgo los recursos de la salud pública.

ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS DE SALUD (ASES)

Esta Ilustre Comisión tuvo la oportunidad de examinar los comentarios presentados por la **Administración de Seguros de Salud (ASES)** quien presentó su Memorial Explicativo por conducto de su Director Ejecutivo, Lcdo. Carlos A. Santiago Rosario, expresándose en contra de la aprobación de la medida. No obstante, reconoció la intención legislativa dirigida a fortalecer la eficiencia, transparencia y agilidad del sistema de salud, particularmente en el manejo de reclamaciones de servicios médicos.



ASES explicó su marco legal y funcional, destacando que fue creada mediante la Ley Núm. 72-1993 con el propósito de administrar el Plan de Salud del Gobierno (Plan Vital) y garantizar acceso equitativo a servicios médico-hospitalarios. Asimismo, señaló que dicho modelo ha permitido ampliar la cobertura de salud a aproximadamente un 46% de la población de Puerto Rico, sustentado en fondos federales y estatales.

En cuanto al funcionamiento operacional, detalló que ha implementado metodologías avanzadas de pago, como el sistema APR-DRG, con el fin de estandarizar y ajustar los reembolsos conforme a la complejidad de los casos clínicos. Además, puntualizó que existen mecanismos contractuales robustos con las organizaciones de servicios de salud (MCO's), los cuales regulan pagos, cumplimiento, transparencia y calidad de servicios, incluyendo ciclos de pago obligatorios, penalidades por incumplimiento y requisitos de red adecuada de proveedores.

ASES expuso que posee amplias facultades de fiscalización mediante su Oficina de Cumplimiento, la cual realiza auditorías, investigaciones e intervenciones periódicas para asegurar el cumplimiento con estándares estatales y federales, particularmente bajo el marco del 42 CFR 438. Igualmente, indicó que cuenta con autoridad para imponer sanciones económicas a las aseguradoras en caso de incumplimiento, conforme al Reglamento Núm. 8446 y disposiciones contractuales vigentes.

Por otro lado, resaltó la intervención de la Oficina del Comisionado de Seguros, la cual supervisa la solvencia financiera de las aseguradoras y exige niveles adecuados de capitalización, lo que constituye un mecanismo adicional de protección al sistema de salud y a los proveedores.

En cuanto a la propuesta de creación del Fondo REMESA, la ASES argumentó que dicha iniciativa resultaría redundante, ya que actualmente existe un fondo de reserva dentro

del Plan Vital. En ese sentido, advirtió que la imposición de reservas adicionales podría generar un impacto adverso en la liquidez del sistema, afectando la cadena de pagos a proveedores y la estabilidad del modelo de salud.

Finalmente, la ASES concluyó que la medida, según redactada, duplica facultades y mecanismos ya existentes bajo su Ley Habilitadora y estructura contractual, por lo que no puede apoyar la aprobación de la medida.

OFICINA COMISIONADO DE SEGUROS (OCS)



Examinamos, de igual forma, los comentarios presentados por la **Oficina de Comisionado de Seguros (OCS)** quien presentó su Memorial Explicativo por conducto de su Comisionada de Seguros, Lcda. Suzette Del Valle Vázquez, expresándose a favor de la aprobación del Proyecto, sujeto a enmiendas. Reconoció la finalidad loable de la medida y expuso que la problemática identificada en la Exposición de Motivos relacionada con cargas administrativas excesivas, dilaciones en pagos, redes cerradas y procesos de credencialización onerosos incide negativamente en la operación de los proveedores de salud.

No obstante, en cuanto al proceso de credencialización, la OCS señaló que el término de sesenta (60) días propuesto en el Proyecto resulta incongruente con el marco legal vigente, ya que el Código de Seguros de Salud de Puerto Rico, según enmendado por la Ley Núm. 73-2024, establece un término más favorable de treinta (30) días. En consecuencia, recomendó armonizar la medida con dicha normativa vigente, así como mantener disposiciones relacionadas con la prohibición de redes cerradas y la facultad del Secretario de Salud para ordenar su apertura cuando se afecte el acceso a servicios.

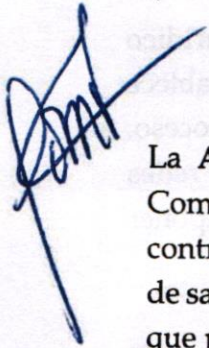
Por otro lado, respecto a la creación del Sistema REMESA como plataforma exclusiva para el procesamiento de reclamaciones, la OCS advirtió que la medida no contempla una asignación presupuestaria ni define la entidad responsable de su implementación y mantenimiento. Además, indicó que dicho sistema debe cumplir con los requisitos federales establecidos bajo la Ley HIPAA y las normas de codificación electrónica aplicables.

En relación con el pago de reclamaciones, puntualizó que actualmente el ordenamiento jurídico, mediante el Capítulo 30 del Código de Seguros de Puerto Rico, regula el pago puntual dentro de un término de treinta (30) días, imponiendo penalidades por

incumplimiento. En ese sentido, avaló propuestas dirigidas a reducir los términos de adjudicación y pago a quince (15) días, resolver disputas en siete (7) días e imponer intereses por atraso, entendiendo que tales medidas fomentarían mayor agilidad, uniformidad regulatoria y certeza financiera para los proveedores.

Finalmente, la OCS expresó su respaldo general a iniciativas que agilicen los procesos de reclamaciones, pero recomendó que la medida sea atemperada al marco legal vigente, considere la viabilidad fiscal del sistema propuesto y tome en cuenta el insumo de entidades como el Departamento de Salud y la Administración de Seguros de Salud (ASES), en atención a su peritaje.

ASOCIACIÓN DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS (ACODESE)



La Asociación de Compañías de Seguro (ACODESE) compareció ante esta Ilustre Comisión por conducto de su Directora Ejecutiva, Lcda. Israelia Pernas, expresándose en contra de la aprobación de la medida. Aunque reconoció los retos que enfrenta el sistema de salud, planteó la necesidad de adoptar un enfoque balanceado y fiscalmente sostenible que proteja tanto a los proveedores como a la estabilidad del sistema asegurador.

En ese contexto ACODESE, señaló que la problemática descrita en la Exposición de Motivos responde a múltiples factores estructurales, tales como la composición demográfica, el aumento en costos operacionales, la reducción de pacientes y deficiencias administrativas en algunas instituciones hospitalarias. No obstante, advirtió que las soluciones propuestas por la pieza legislativa podrían generar consecuencias adversas para la sostenibilidad del sistema.

En cuanto al alcance de la medida, indicó que la definición de asegurador incluida en el Proyecto podría entrar en conflicto con el ordenamiento federal, particularmente en el ámbito de Medicare Advantage, el cual ha sido reconocido como un campo ocupado por legislación federal, por lo que no puede ser regulado por legislación local.

Respecto al Sistema REMESA, ACODESE argumentó que trastoca un esquema ya regulado por el Código de Seguros de Puerto Rico, específicamente en el Capítulo 30 sobre pago puntual de reclamaciones. En ese sentido, destacó que el marco vigente ya establece términos claros y razonables, incluyendo un periodo de treinta (30) días para el pago de reclamaciones y penalidades por incumplimiento. Asimismo, advirtió que la reducción de términos a quince (15) días para adjudicación y veinticuatro (24) horas para

pago resulta operacionalmente inviable, ya que ignora los procesos complejos de validación, elegibilidad, coordinación de beneficios, detección de fraude y cumplimiento contractual.

De igual forma, expuso que la creación de un sistema paralelo como REMESA podría entrar en conflicto con la normativa federal aplicable bajo la Ley HIPAA y los estándares uniformes establecidos para el procesamiento de transacciones electrónicas, incluyendo la función de los *clearing houses*. Planteó, que ello generaría duplicidad regulatoria e inconsistencias operacionales.



Referente al proceso de credencialización, ACODESE indicó que el ordenamiento jurídico vigente ya contempla un sistema uniforme mediante la Ley Núm. 73-2023, que establece términos de treinta (30) días y mecanismos centralizados para agilizar dicho proceso. Asimismo, resaltó que la regulación vigente también atiende la adecuación de las redes de proveedores conforme a estándares federales, por lo que no resulta necesario imponer nuevas disposiciones.

Sobre la creación del Fondo REMESA, ACODESE advirtió que la propuesta carece de claridad en cuanto a su estructura, administración y criterios de distribución, además de no estar sustentada por un análisis actuarial o fiscal. A su vez, indicó que la utilización de fondos del Plan Vital podría resultar incompatible con requisitos federales aplicables a Medicaid y Medicare.

En síntesis, ACODESE concluyó que la medida, según propuesta, duplica marcos regulatorios ya existentes, genera inconsistencias normativas y podría imponer cargas operacionales adicionales al sistema, por lo que reiteró su rechazo a la aprobación del Proyecto del Senado 867.

ASOCIACIÓN MÉDICA DE PUERTO RICO

Por su parte, la **Asociación Médica de Puerto Rico** presentó su Memorial Explicativo ante esta Comisión, por conducto de su Presidente, el Dr. Edgardo N. Nazario Burgos, endosando la pieza legislativa sujeto a la incorporación de sus recomendaciones.

Comenzó su exposición destacando que la medida atiende problemáticas reales que afectan el funcionamiento del sistema de salud y la capacidad de los proveedores para ofrecer servicios. En ese contexto, señaló que los médicos, hospitales y proveedores han

enfrentado históricamente retrasos en el pago de reclamaciones, cargas administrativas excesivas, demoras en procesos de credencialización, limitaciones en redes de servicios y presiones financieras crecientes, lo cual incide directamente en el acceso y la continuidad del cuidado médico para los pacientes. A tales efectos, considera acertado que el Proyecto proponga mecanismos dirigidos a agilizar reclamaciones, aumentar la transparencia, mejorar la credencialización y atender la retención de profesionales de la salud.

No obstante, la Asociación Médica detalló recomendaciones específicas para fortalecer la medida. En cuanto al procesamiento y pago de reclamaciones, reconoció la importancia de agilizar los pagos, pero sugirió ajustar el término propuesto de veinticuatro (24) horas para el pago, recomendando un periodo de hasta siete (7) días, en armonía con prácticas regulatorias en otras jurisdicciones, a fin de garantizar viabilidad operacional.

En relación con las penalidades por atraso, indicó que la tasa propuesta de 0.5% diario resulta excesiva en comparación con estándares en Estados Unidos, por lo que recomendó establecer una penalidad más razonable de aproximadamente 1% mensual, que incentive el cumplimiento sin generar distorsiones regulatorias.

Respecto a los procesos de credencialización, indicó coincidir con la intención del Proyecto de establecer términos claros y ágiles, destacando que estos retrasos constituyen uno de los principales obstáculos para la integración de médicos a las redes de servicios y el acceso de los pacientes a atención especializada.

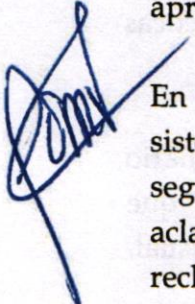
Asimismo, en cuanto al mecanismo de aceptación automática de reclamaciones, advirtió que su implementación podría generar conflictos administrativos, por lo que propuso una alternativa que permita presumir la validez de la reclamación para efectos de pago inicial, manteniendo la posibilidad de auditorías posteriores para salvaguardar la integridad del sistema.

En relación con el Fondo REMESA, la Asociación reconoció su potencial como herramienta para fortalecer la estabilidad financiera del sistema, pero advirtió la necesidad de evaluar cuidadosamente su estructura para asegurar compatibilidad con requisitos federales, particularmente aquellos relacionados con fondos de Medicaid. En ese sentido, sugirió considerar un modelo de fondo rotatorio que permita adelantar pagos a proveedores y luego reembolsarse con los pagos de las aseguradoras.

Finalmente, la Asociación Médica de Puerto Rico concluyó que el Proyecto constituye un esfuerzo legislativo meritorio y reiteró su respaldo general a la medida, sujeto a las recomendaciones planteadas para asegurar su implementación efectiva y sostenible, en beneficio del sistema de salud y de los pacientes.

ASOCIACIÓN DE HOSPITALES DE PUERTO RICO

Esta Ilustre Comisión tuvo la oportunidad de examinar los comentarios presentados por la **Asociación de Hospitales de Puerto Rico** quien presentó su Memorial Explicativo por conducto de su Presidente Ejecutivo, Lcdo. Jaime Plá Cortés, expresándose a favor de la aprobación de la medida.



En términos generales, la Asociación de Hospitales respaldó el establecimiento de un sistema obligatorio de sometimiento electrónico y pago automático de reclamaciones, según dispuesto en el Artículo 4 del Proyecto. No obstante, es de la opinión que se debe aclarar expresamente que el requisito de sometimiento electrónico aplique a toda reclamación, aun cuando el proveedor no sea proveedor participante de la aseguradora o plan médico. Planteó que, en la práctica, los hospitales y otros proveedores continúan prestando servicios a pacientes cubiertos por planes con los cuales no existe un contrato directo, particularmente en escenarios de emergencia. Acentuó que, para que el sistema REMESA sea verdaderamente funcional, las aseguradoras deben contar con la obligación y la capacidad de procesar estas reclamaciones como "*non-participating providers*" y adjudicarlas, ya sea para pago o denegación, conforme a los criterios aplicables; o de lo contrario, se corre el riesgo de perpetuar lagunas que generen rechazos automáticos y atrasos adicionales.

De igual forma, resaltó la necesidad de atender el alcance y la viabilidad del término de siete días establecido para la resolución de disputas, expuso que la ley debe definir con precisión qué se entiende por "disputa" y si este concepto incluye solicitudes de ajuste, reconsideraciones, correcciones o controversias que requieren evaluación clínica o contractual. Subrayó, que un término uniforme de siete días para todo tipo de controversia no refleja la realidad operacional de los procesos de revisión y puede resultar impracticable, tanto para aseguradoras como para proveedores. Por ello, favoreció que se establezca un esquema más flexible que distinga entre disputas administrativas simples y aquellas que conllevan análisis clínico o documental complejo, proveyendo términos razonables que garanticen agilidad sin sacrificar rigurosidad.

En cuanto al Artículo 5, relacionado con credencialización y apertura de redes, la Asociación de Hospitales entiende meritorio el establecimiento de términos máximos para adjudicar solicitudes y el efecto de aprobación automática ante la falta de determinación dentro del término establecido. Sin embargo, recomendó que la Ley disponga expresamente que la relación contractual y sus efectos económicos sean retroactivos a la fecha de radicación de la solicitud de credencialización, siempre que esta sea finalmente aprobada. En cuanto a esto, explicó que, actualmente, muchos proveedores, incluidos hospitales y médicos, enfrentan pérdidas significativas porque, aunque la aseguradora demore meses en completar el proceso, no reconoce retroactividad alguna. Ilustró, que esta situación desalienta la integración de proveedores a las redes y agrava la escasez de recursos disponibles.



De otra parte, la Asociación de Hospitales impartió su apoyo a la política pública de prohibir redes cerradas y recomienda que se aclare que dicha prohibición incluye no limitar el lugar de servicio donde el proveedor pueda ofrecer servicios, tales como: hospitales, salas de emergencia, centros ambulatorios u otros escenarios clínicos autorizados. Argumentó que, de nada vale que un proveedor esté credencializado si se le impide facturar o prestar servicios en determinados lugares esenciales para la continuidad del cuidado.

Referente a "*Any Willing Provider*", sugirió que provea para que todo proveedor que desea participar y cumpla con los criterios no se le limite el acceso. De igual recomendó requerir que las denegaciones de servicios y/o reducciones en pago sean atendidas electrónicamente en ese proceso de revisión.

Finalmente, trajo ante la atención de esta Comisión que muchos médicos y proveedores mantienen contratos con entidades externas especializadas en procesos de credencialización, las cuales realizan verificaciones primarias y secundarias conforme a estándares reconocidos. Propuso que el Proyecto contemple y valide estos mecanismos, permitiendo que las aseguradoras acepten dichos procesos para evitar duplicidad, reducir cargas administrativas y agilizar la integración de proveedores a las redes.

A raíz de lo anterior, la Asociación de Hospitales reiteró su respaldo al Proyecto del Senado 867, entendiendo que las recomendaciones aquí expuestas fortalecen la medida y promueven una implantación efectiva y balanceada.

ASOCIACIÓN DE SALUD PRIMARIA DE PUERTO RICO

Esta Distinguida Comisión tuvo la oportunidad de examinar los comentarios presentados por la **Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico** quien presentó su Memorial Explicativo por conducto de su Directora Ejecutiva, Dra. Darielys Cordero, expresándose a favor de la aprobación de la medida. Destacó su rol como entidad representativa de los Centros de Salud Primaria (FQHCs), los cuales brindan servicios esenciales a poblaciones vulnerables en múltiples municipios de la Isla.



En ese contexto, destacó la importancia de la atención primaria como primer nivel de contacto del sistema de salud, así como el impacto significativo que tienen los Centros de Salud Primaria en la prestación de servicios preventivos y el manejo de condiciones crónicas. Asimismo, señaló que estos centros dependen de múltiples fuentes de financiamiento, incluyendo reclamaciones a Medicaid, Medicare, planes privados, pagos directos y subvenciones federales.

En cuanto a la problemática del sistema actual, la ASPPR indicó que los retrasos en el procesamiento de reclamaciones generan efectos adversos significativos, tales como aumento en cuentas por cobrar, dependencia de líneas de crédito, costos financieros adicionales y limitaciones en el capital operacional. De igual forma, advirtió que dichas dilaciones afectan la capacidad de los centros para cumplir con sus obligaciones, incluyendo el pago de nómina, la retención de talento médico, la expansión de servicios y el cumplimiento con métricas federales.

Respecto al Sistema REMESA propuesto en la medida, explicó que este introduce términos obligatorios para la adjudicación y pago de reclamaciones, así como mecanismos de aceptación automática, intereses por mora y herramientas de transparencia. En ese sentido, sostuvo que estas disposiciones constituyen una herramienta válida de política pública dirigida a corregir dilaciones administrativas y desequilibrios contractuales que afectan el interés público.

En cuanto a los procesos de credencialización, la ASPPR señaló que los retrasos actuales pueden provocar pérdidas operacionales y limitar el acceso a servicios en comunidades con escasez de profesionales de la salud. Por ello, resaltó que la fijación de términos claros y la aprobación automática ante inacción administrativa fortalecen la certeza jurídica y evitan prácticas dilatorias.

Sobre el Fondo REMESA, la Asociación reconoció su potencial para fortalecer la estabilidad financiera del sistema de salud y apoyar la retención de subespecialistas. No obstante, indicó la necesidad de evaluar su viabilidad financiera, particularmente en cuanto a la fuente de ingresos y su compatibilidad con los fondos del Plan Vital.

Finalmente, la ASPPR concluyó que la medida atiende problemáticas reales del sistema de salud y, en términos generales, respaldó la aprobación del Proyecto del Senado 867, sujeto a la evaluación de su viabilidad financiera en relación con el Fondo REMESA.

PLAN DE SALUD MENONITA



De igual forma, la Comisión evaluó los comentarios presentados por la **Plan de Salud Menonita de Puerto Rico (PSM)** quien presentó su Memorial Explicativo por conducto de su Principal Asesora Legal, Yamilca Ortiz Carrión, expresándose en contra de la aprobación de la medida. No obstante, reconoció que la medida parte de preocupaciones legítimas sobre la crisis del sistema de salud en Puerto Rico.

PSM advirtió que las disposiciones propuestas podrían generar distorsiones fiscales, regulatorias y operacionales significativas, afectando la estabilidad del mercado de seguros de salud, el acceso de los pacientes y la sostenibilidad presupuestaria del Gobierno. En cuanto al marco legal, señaló que el Proyecto podría entrar en conflicto con legislación federal aplicable, particularmente bajo el esquema de ERISA y el programa de Medicare Advantage, al imponer términos obligatorios de pago, aceptación automática y sanciones económicas que podrían ser impugnadas por interferir con dicho campo regulado.

Respecto al impacto fiscal, indicó que la creación de una reserva obligatoria de entre 5% y 10% del Plan Vital podría implicar una reasignación sustancial de recursos, reduciendo fondos disponibles para servicios clínicos, generando presiones presupuestarias adicionales al Gobierno y limitando la flexibilidad administrativa. Asimismo, destacó la ausencia de análisis actuarial que sustente la necesidad y viabilidad de dicha reserva.

En cuanto a las penalidades propuestas, PSM advirtió que la imposición de intereses de 0.5% diario resulta excesiva y potencialmente confiscatoria, lo que podría desincentivar la participación de aseguradoras y provocar aumentos en primas.

Desde la perspectiva operacional, la aseguradora expuso que disposiciones como el pago obligatorio en veinticuatro (24) horas, la aceptación automática por silencio administrativo y la resolución de disputas en siete (7) días comprometen la integridad del sistema, al limitar procesos esenciales de validación, auditoría, detección de fraude y análisis clínico. En ese sentido, señaló que estas medidas podrían aumentar el riesgo de pagos indebidos y debilitar los controles regulatorios.

Por otro lado, en relación con la apertura obligatoria de redes, planteó que esta podría interferir con modelos actuariales, limitar la libertad contractual, aumentar los costos médicos y afectar la calidad del cuidado coordinado, además de reducir la participación de aseguradoras en el mercado. Asimismo, indicó que el conjunto de medidas propuestas podría traducirse en un incremento en primas, reducción de opciones para los pacientes y un deterioro en la estabilidad del sistema de seguros.

Finalmente, el Plan de Salud Menonita concluyó que, aunque el Proyecto responde a un diagnóstico válido, su diseño actual genera conflictos legales, cargas financieras desproporcionadas y riesgos sistémicos significativos, por lo que recomendó que la medida no sea aprobada en su forma actual.

MMM HOLDINGS, LLC

Esta Honorable Comisión también tuvo la oportunidad de examinar los comentarios presentados por **MMM Holdings, LLC** quien presentó su Memorial Explicativo por conducto de su Director Seniors en Relaciones con Gobierno, Comunidad y Asuntos Públicos, Jonathan A. Bonet Rivera endosando la medida, aunque identificó ciertas deficiencias en el texto.

MMM, reconoció el esfuerzo legislativo dirigido a modernizar el sistema de reclamaciones mediante la implementación de mecanismos de eficiencia, transparencia y agilidad. Señaló que, en su carácter de entidad que administra el programa federal de Medicare Advantage, existen limitaciones sustantivas para adoptar una postura categórica sobre la medida, dado que dicho programa se rige exclusivamente por normativa federal. En ese sentido, explicó que la legislación estatal no puede interferir con el marco regulatorio federal, conforme a la cláusula de preeminencia establecida en la Ley de Seguro Social federal.

A tales efectos, la entidad advirtió que varias disposiciones del Proyecto podrían entrar en conflicto con la regulación federal aplicable, particularmente en lo relativo a términos obligatorios de pago, aceptación automática de reclamaciones y estructuras de supervisión, los cuales podrían interferir con los estándares establecidos por *Centers for Medicare and Medicaid Services* (CMS).

En cuanto al Sistema REMESA, MMM expuso que la imposición de un término de quince (15) días para adjudicación y veinticuatro (24) horas para pago podría resultar incompatible con los procesos de validación, auditoría y control requeridos, especialmente en el contexto de programas federales. Asimismo, indicó que tales disposiciones podrían eliminar mecanismos esenciales de análisis de reclamaciones, aumentando el riesgo de pagos indebidos y afectando la sostenibilidad financiera de los planes médicos.

Respecto a las penalidades por atraso, la aseguradora advirtió que la imposición de intereses podría generar conflictos con las normativas federales sobre reembolsos y manejo de costos, afectando la viabilidad económica de los planes.

En relación con el proceso de credencialización, MMM señaló que la extensión del término a sesenta (60) días y la aprobación automática por silencio administrativo podrían generar riesgos para la calidad y seguridad de los servicios de salud. Además, planteó que la prohibición de redes cerradas podría limitar la capacidad de los planes para gestionar sus redes de manera eficiente y cumplir con estándares de calidad.

Por otro lado, en cuanto al Fondo REMESA y las disposiciones de transparencia, MMM reconoció la intención de fortalecer la estabilidad del sistema, pero recomendó que se evalúe la capacidad financiera del Plan Vital, particularmente a través de la Administración de Seguros de Salud (ASES), y que se garantice la coordinación con las agencias federales para evitar duplicidad de beneficios o conflictos regulatorios.

Finalmente, MMM Holdings concluyó que, de no atenderse las reservas y recomendaciones planteadas, la entidad no podría respaldar la medida en su estado actual, reiterando su disposición de colaborar con la Comisión para mejorar la propuesta legislativa.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Salud certifica que el P. del S. 867 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

Tras un análisis integral del **Proyecto del Senado 867**, a la luz de la Exposición de Motivos y de los memoriales explicativos presentados por entidades gubernamentales, aseguradoras, asociaciones profesionales y organizaciones de servicios de salud, esta Honorable Comisión de Salud presenta su Informe Positivo sobre la pieza legislativa.



Aunque agencias reguladoras como la Administración de Seguros de Salud (ASES), la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) y la Asociación de Compañías de Seguros (ACODESE) expresaron inicialmente serios reparos operacionales y legales especialmente en torno a la duplicidad de fiscalización, el conflicto con leyes federales como ERISA o Medicare Advantage y la viabilidad del propuesto Fondo REMESA, la Comisión logró subsanar estas deficiencias medulares mediante la incorporación de enmiendas incorporadas a la luz de los memoriales recibidos y la legislación vigente (Código de Seguros de Puerto Rico, Ley 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada) en el Entirillado Electrónico.

En primer término, se desprendió un consenso generalizado entre los deponentes en cuanto a la existencia de deficiencias sustantivas en el sistema de procesamiento de reclamaciones en Puerto Rico. Diversas entidades reconocieron que los retrasos en los pagos, la excesiva carga administrativa, las demoras en los procesos de credencialización y las limitaciones en el acceso a redes de proveedores han generado efectos adversos tanto para los profesionales de la salud como para las instituciones hospitalarias, incidiendo, en última instancia, sobre la continuidad y calidad de los servicios ofrecidos a los pacientes. En ese sentido, la intención legislativa del Proyecto fue ampliamente validada como una respuesta legítima a problemáticas reales del sistema de salud.

No obstante, del análisis comparado de los memoriales surgieron divergencias sustantivas en cuanto a los mecanismos propuestos para atender dichas deficiencias. Por un lado, organizaciones que representan a proveedores de servicios de salud respaldaron la creación de estructuras regulatorias más estrictas que impongan términos definidos

para la adjudicación y pago de reclamaciones, al entender que tales medidas corrigen desequilibrios contractuales y dilaciones administrativas que afectan el interés público. Mientras que las entidades del sector asegurador y organismos reguladores advirtieron que el Proyecto, según redactado, introduce cambios estructurales que podrían generar efectos adversos de mayor envergadura.

Asimismo, los memoriales advirtieron que, según redactada, la medida podría tener posibles conflictos con el ordenamiento jurídico federal. Diversos comparecientes indicaron que la aplicación de la medida a programas como Medicare Advantage podría resultar incompatible con la doctrina de ocupación de campo federal, lo cual expondría la legislación a impugnaciones judiciales y potencial invalidez parcial. De otra parte, en el ámbito fiscal, los memoriales coincidieron al advertir sobre el impacto potencial de la creación del Fondo REMESA. No obstante, se reconoció que la estabilización financiera del sistema y la retención de profesionales de la salud también constituyen objetivos necesarios.

De igual forma, la Comisión evaluó los señalamientos relacionados con la duplicidad regulatoria. No obstante, lo anterior, reconocemos que el estado actual del sistema evidencia la necesidad de reformas dirigidas a fortalecer la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en el procesamiento de reclamaciones.

En virtud de lo anterior, esta Comisión determinó que el **Proyecto del Senado 867** atiende una necesidad real y apremiante. Luego de realizar un análisis exhaustivo de la pieza legislativa y analizar los argumentos y comentarios esbozados, se pudieron identificar algunos cambios que corresponden para lograr una mejor implementación de la medida. Es por esto, que la Comisión de Salud implementó los siguientes cambios o sugerencias:

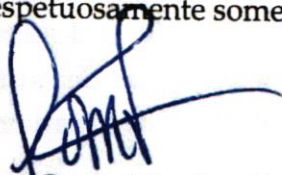
- Se atemperaron los términos de respuestas a reclamaciones con el Artículo 30 del Código de Seguros (Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico; MMM Holdings; Asociación de Médica de Puerto Rico).
- Se incorporó la definición del término "disputa", según recomendado por la Asociación de Hospitales.
- Se acogió la recomendación de la Asociación de Hospitales que indica que resulta indispensable que la ley disponga expresamente que la relación contractual y sus efectos sean retroactivos a la fecha de radicación de la solicitud de credencialización, siempre que esta sea finalmente aprobada.

- Se aclaró que la prohibición a redes cerradas incluye no limitar el lugar de servicio donde el proveedor pueda ofrecer servicios. (Asociación de Médicos de Puerto Rico).
- Se modificó el % de tasa de intereses moratorios para cumplir con la tasa aplicable bajo la reglamentación federal (Departamento de Salud; Plan de Salud Menonita; Asociación Médica de Puerto Rico).
- Se eliminó el Fondo de Remesa por recomendación del Departamento de Salud ya que estaba vinculado a fondos federales.

CONCLUSIÓN

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, luego de la consideración correspondiente, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su Informe, **RECOMENDANDO LA APROBACIÓN** del **Proyecto del Senado 867** con las enmiendas contenidas en el Entrillado Electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,



Juan Oscar Morales Rodríguez
Presidente
Comisión de Salud

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 867

4 de diciembre de 2025

Presentado por el señor Rivera Schatz (*Por petición*)

Referido a la Comisión de Salud

LEY



Para crear la "Ley de la Reforma Médica para la Eficiencia, Salud y Agilidad", a los fines de crear eficiencia, transparencia y agilidad en la operación del sistema de salud de Puerto Rico mediante la regulación del proceso de reclamaciones sometidas por los proveedores de servicios de salud a las aseguradoras o planes médicos, tanto en la esfera privada como bajo el Plan Vital; ~~para crear el Fondo REMESA;~~ y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

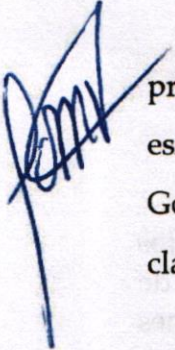
El sistema de salud de Puerto Rico enfrenta una crisis estructural que afecta la calidad, continuidad y eficiencia de los servicios médicos. Los hospitales se encuentran operando bajo presión financiera severa debido a tarifas insuficientes, alza en costos operacionales y, especialmente, retrasos prolongados en los pagos provenientes de las aseguradoras.

Los proveedores de servicios de salud, incluyendo médicos, subespecialistas, hospitales, laboratorios, centros de salud, proveedores de salud mental y profesionales aliadas, experimentan una carga administrativa extrema producto de procesos

burocráticos lentos, reclamaciones denegadas, redes cerradas y demoras injustificadas en credencialización.

Los médicos subespecialistas enfrentan una crisis particular debido a la dificultad para integrarse a redes, la falta de incentivos contributivos, los procesos engorrosos de certificación y los altos costos de sus préstamos estudiantiles.

El sistema de reclamaciones vigente carece de eficiencia y transparencia. La ausencia de un método obligatorio de pago electrónico automático permite que los atrasos en pagos se extiendan por semanas o meses, afectando directamente la operación de hospitales y proveedores.



Esta Ley regula específicamente el proceso de reclamaciones sometidas por los proveedores de servicios de salud a las aseguradoras o planes médicos, tanto en la esfera privada como bajo el Plan Vital. Además, regula la relación operacional entre el Gobierno, los proveedores de salud y los planes médicos, asegurando uniformidad, claridad y eficiencia en el procesamiento de reclamaciones.

El Plan Vital maneja entre \$2,200 y \$2,400 millones anuales, fondos que deben utilizarse de forma transparente, estratégica y eficiente. Es imperativo garantizar que estos recursos se distribuyan apropiadamente para fortalecer la infraestructura hospitalaria, retener profesionales y asegurar servicios médicos oportunos.

La Esta Ley ~~REMESA~~ moderniza el sistema mediante la implementación de pagos automáticos obligatorios, apertura de redes, procesos de credencialización acelerados, y auditorías periódicas ~~y la creación de un Fondo de REMESA~~ para promover la estabilidad financiera y profesional del sistema de salud.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Artículo 1.- Título.

1 Esta Ley se conocerá como la "Ley de la Reforma Médica para Eficiencia, Salud y
2 Agilidad" o "Ley REMESA". Para todos los fines legales y administrativos, podrá
3 abreviarse como "REMESA".

4 Artículo 2.- Declaración de Política Pública.

5 Se declara política pública del Gobierno de Puerto Rico:

6 (a) Garantizar que todo proveedor reciba pagos puntuales y justos por servicios
7 prestados.

8 (b) Establecer obligatoriedad en el uso de sistemas electrónicos para la
9 presentación, procesamiento y pago de reclamaciones.

10 (c) Eliminar la burocracia que afecta la entrega de servicios médicos y
11 hospitalarios.

12 (d) Asegurar la disponibilidad adecuada de médicos, subespecialistas y
13 profesionales de la salud.

14 (e) Prevenir la práctica de redes cerradas sin justificación basada en evidencia.

15 (f) Promover la estabilidad financiera y operativa de hospitales, centros de salud
16 y proveedores.

17 (g) Retener profesionales mediante incentivos contributivos y programas de
18 repago.

19 (h) Asegurar uso transparente de fondos públicos mediante auditorías estrictas.

20 Artículo 3.- Definiciones.

21 Para fines de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a
22 continuación se expresa:

~~(a) "Proveedor Médico" o "Proveedor de Servicios de Salud": Toda persona natural o jurídica autorizada a ofrecer servicios clínicos, diagnósticos o terapéuticos, incluyendo médicos, subespecialistas, hospitales, farmacias, laboratorios, proveedores de salud mental, terapeutas y profesionales aliadas.~~

~~(b) "Aseguradora" o "Plan Médico": Toda entidad autorizada a emitir o administrar pólizas de salud, Medicare Advantage o fondos públicos del Plan Vital.~~

~~(c) "Reclamación": Toda facturación sometida por un proveedor médico a una aseguradora por servicios prestados.~~

~~(d) "Reclamación procesable": Reclamación que contiene la información requerida para adjudicación.~~

~~(e) "Pago automático": Desembolso electrónico obligatorio dentro de los términos de esta Ley.~~

~~(f) "Credencialización": Evaluación de cualificaciones del proveedor.~~

~~(g) "Fondo de REMESA": Fondo especial creado por esta Ley para fortalecer proveedores y hospitales.~~

(a) "Aseguradora" o "Plan Médico": Toda entidad autorizada a emitir o administrar pólizas de salud, Medicare Advantage o fondos públicos del Plan Vital.

(b) "Credencialización": Evaluación de cualificaciones del proveedor.

(c) "Disputa": Se refiere a solicitudes de ajuste, reconsideraciones, correcciones o controversias que requieren evaluación clínica o contractual.

(d) "Pago automático": Desembolso electrónico obligatorio dentro de los términos de esta Ley.

(e) "Proveedor Médico" o "Proveedor de Servicios de Salud": Toda persona natural o jurídica autorizada a ofrecer servicios clínicos, diagnósticos o terapéuticos, incluyendo médicos, subespecialistas, hospitales, farmacias, laboratorios, proveedores de salud mental, terapeutas y profesionales aliadas.

(f) "Reclamación": Toda facturación sometida por un proveedor médico a una aseguradora por servicios prestados.

(g) "Reclamación procesable": Reclamación que contiene la información requerida para adjudicación.

Artículo 4.- Sistema REMESA de Pago Automático.

El sistema REMESA regulará exclusivamente reclamaciones sometidas por proveedores médicos a planes médicos o aseguradoras. El proceso incluirá lo siguiente:

(a) Toda reclamación deberá someterse electrónicamente. (b) La aseguradora deberá adjudicar la reclamación en un término máximo de quince (15) días. (c) Toda reclamación procesable deberá pagarse dentro de ~~veinticuatro (24) horas~~ un término no mayor de siete (7) días. (d) La falta de respuesta en ~~quince (15)~~ treinta (30) días constituirá aceptación automática. (e) Todo atraso conllevará intereses de ~~0.5~~ 0.03% por cada día de retraso. (f) Se establecerá un portal digital para seguimiento continuo. (g) Toda disputa deberá resolverse en un término de siete (7) días, salvo se pueda demostrar justa causa para la demora. (h) El Comisionado de Seguros fiscalizará su cumplimiento.

Artículo 5.-Credencialización y Apertura de Redes.

Se dispone que: (a) Toda solicitud de credencialización deberá adjudicarse en un

1 término máximo de sesenta (60) días. (b) Si la aseguradora no responde en dicho
2 término, la solicitud se considerará aprobada. (c) Se prohíben redes cerradas y que se
3 limite el lugar donde el proveedor pueda ofrecer servicios, salvo justificación basada en
4 evidencia. (d) El Secretario de Salud podrá ordenar la apertura de redes cuando el
5 acceso esté comprometido. (e) Se creará el Programa REMESA de Repago de Préstamos
6 para Subespecialistas, como medida de retención. (f) La relación contractual y sus efectos
7 serán retroactivos a la fecha de radicación de la solicitud de credencialización de ser finalmente
8 aprobada.

9 **Artículo 6. Fondo de REMESA.**

10 ~~El Fondo de REMESA se constituirá mediante una reserva de entre 5-10% del~~
11 ~~Plan Vital. Sus usos permitidos serán:~~

12 ~~(a) Estabilización hospitalaria.~~

13 ~~(b) Retención de personal clínico.~~

14 ~~(c) Repago de préstamos para subespecialistas.~~

15 ~~(d) Programas de incentivos regionales.~~

16 ~~Se dispone que, los fondos no podrán utilizarse para gastos administrativos de~~
17 ~~aseguradoras.~~

18 **Artículo 76.-Transparencia y Fiscalización.**

19 Las aseguradoras deberán: (a) Presentar informes trimestrales sobre tiempos de
20 pago, denegaciones y utilización. (b) Someterse a auditorías anuales. (c) Publicar
21 información en el Portal REMESA. (d) Facilitar acceso completo al Gobierno de Puerto
22 Rico para su fiscalización.

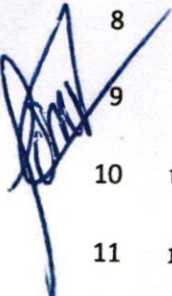
1 Artículo ~~87~~.-Reglamentación.

2 Las agencias pertinentes deberán en un término de ciento ochenta (180) días
3 desde la aprobación de esta Ley, adoptar la reglamentación necesaria para la
4 implementación de lo aquí dispuesto.

5 Artículo ~~98~~.-Supremacía.

6 Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra disposición de
7 ley o reglamento que no estuviere en armonía con lo aquí establecido.

8 Artículo ~~109~~.- Separabilidad.



9 Si alguna disposición de esta Ley fuere declarada inconstitucional o inválida por
10 un tribunal de jurisdicción competente, tal determinación no afectará la validez de las
11 restantes disposiciones, las cuales permanecerán en pleno vigor y efecto.

12 Artículo ~~110~~.- Vigencia.

13 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.